

מטרה

שיפור הפרפוזיה במצב הלם הנגרם כתוצאה מברדיקרדיה קשה.

התוויות

ברדיקרדיה סימפטומטית המלווה בירידה בפרפוזיה.

סיבוכים אפשריים

- כאב או אי־נוחות למטופל.
- היעדר תגובה (בשל אי־השגת capture מכני).

דגשים כלליים

- יש לקבוע את שיטת הקיצוב בהתאם למצבו של המטופל. ברירת המחדל של המכשיר היא קיצוב בשיטת Demand. במידת הצורך ניתן להעביר את שיטת הקיצוב למצב FIX.
- לאחר השגת capture חשמלי (נראה במוניטור) יש לוודא השגת capture מכני באמצעות –
 - א. מישוש דפקים פריפריים.
 - ב. שיפור קליני (צבע העור, רמת ההכרה).
 - ג. שיפור במדדים (סטורציה, לחץ דם, ETCO2 במטופל מונשם).

ציוד נדרש

- + מוניטור קורפולס טעון
- + מדבקות קיצוב מותאמות לגיל המטופל
- + סכין גילוח חד־פעמי
- + תרופות לסדציה או אנלגזיה

סדר הפעולות

- הדלק את מכשיר הקורפולס.
- נקה ויבש את העור באזור ההדבקה המיועד. במקרה הצורך גלח שיער מהאזור.
- הדבק את מדבקות הקיצוב (ציר קדמי־אחורי).
- הדלק את מודולת הקיצוב באמצעות לחיצה על כפתור Pacer.
- בחר את קצב הלב הרצוי (לרוב 80 פעימות בדקה).
- העלה בהדרגה את עוצמת הזרם עד השגת capture חשמלי (לרוב סביב 120-130 mah).

7. ודא השגת capture מכני.
8. הגבר את עוצמת הזרם ב־10% מעל הערך שבו הושג ה־capture המכני.
9. תן טיפול אנלגטי או סדטיבי למטופל בהכרה.
10. המשך ניטור רציף.